

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA INFANTO-JUVENIL (BASC-3)

Eje IV: Funcionamiento y Adaptación • Evaluación Multifuente de Conductas Clínicas y Habilidades Adaptativas

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes, 3ª Edición (BASC-3).
Nombre Original	Behavior Assessment System for Children, 3rd Edition (BASC-3; Reynolds & Kamphaus, 2015).
Autores Originales	Cecil R. Reynolds, Ph.D. y Randy W. Kamphaus, Ph.D. (Pearson Assessment, EE.UU.).
Adaptación Hispana	González, Fernández-Pinto, Santamaría et al.; Pearson Clinical España / Hogrefe TEA.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento infanto-juvenil. Evaluación multidimensional adaptativa y patológica.
Tipo de Instrumento	Batería multimétodo y multifuente: Autoinforme (SRP), Padres (PRS) y Tutores/Profesores (TRS).
Población y Rango	Niños y adolescentes de 3 a 18 años (divididos en tramos Infantil, Primaria y Secundaria).
Tiempo de Administración	15 a 25 minutos por cuestionario (aproximadamente 100 a 190 reactivos según forma).
Régimen de Licencia	Comercial / Restringido. Propiedad de Pearson Clinical Assessment. Nivel B/C de cualificación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO INTEGRAL DEL BASC-3

El **BASC-3** de Reynolds y Kamphaus (2015) constituye uno de los sistemas diagnósticos infanto-juveniles más avanzados internacionalmente. El diseño del instrumento se fundamenta en tres pilares metodológicos de la psicopatología del desarrollo:

- Evaluación Multifuente (Triangulación Clínica):** Los problemas emocionales y del comportamiento infantil son altamente dependientes del contexto. La batería cruza la perspectiva del propio menor (SRP), de la familia en el hogar (PRS) y del entorno académico escolar (TRS), identificando discrepancias situacionales cruciales.
- Perspectiva Dual (Patología versus Adaptación):** El BASC-3 no solo mide constructos psicopatológicos clásicos (ansiedad, depresión, agresividad, hiperactividad), sino que cuantifica explícitamente las **Habilidades Adaptativas** (liderazgo, habilidades sociales, comunicación y adaptabilidad), esenciales como factores protectores y predictores pronósticos de recuperación.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍNDICES GLOBALES

Índice Compuesto	Fuentes (Informador)	Escalas Clínicas y Adaptativas Integradas en el BASC-3
Síntomas Conductuales (BSI)	Padres (PRS) / Profesores (TRS)	Resumen global del nivel de afectación patológica psicocomportamental general.
Problemas Exteriorizados	Padres / Profesores	Hiperactividad, Agresividad física/verbal y Problemas de Conducta destructiva.
Problemas Interiorizados	Padres / Profesores / SRP	Ansiedad, Depresión, Somatización, Estrés social y Sentido de incapacidad.
Desajuste Escolar	Autoinforme (SRP) / TRS	Actitud negativa hacia el colegio, actitud hacia los profesores y Búsqueda de sensaciones.
Habilidades Adaptativas	Padres / Profesores / SRP	Adaptabilidad, Habilidades Sociales, Liderazgo, Comunicación funcional y Autoestima.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La baremación y adaptación española (Pearson Clinical, $N > 4.500$ niños y adolescentes) documenta una precisión métrica sobresaliente:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Índices Compuestos	Alfa $\alpha = 0.90 - 0.96$	Extraordinaria fiabilidad en los índices globales BSI, Exteriorizados e Interiores.
Consistencia Escalas Individuales	Alfa $\alpha = 0.78 - 0.89$	Alta precisión en subescalas específicas clínicas y adaptativas en padres y profesores.
Estabilidad Test-Retest	CCI $r = 0.82 - 0.91$	Elevada estabilidad temporal comprobada en reevaluaciones a 4 semanas.
Concordancia Interobservadores	$r = 0.55 - 0.70$ (Padres-Tutores)	Concordancia moderada-alta congruente con la especificidad situacional del comportamiento infantil.
Validez Diagnóstica	AUC ROC > 0.88 (TDAH/TC)	Excelente capacidad de discriminación diagnóstica en TDAH, trastornos disociales y TEA.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN, ÍNDICES DE VALIDEZ Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

• **Opciones de Calificación:** Escalas de frecuencia de 4 niveles para Padres y Profesores: Nunca (0), A veces (1), Frecuentemente (2), Casi siempre (3). En el autoinforme SRP se combinan respuestas Verdadero/Falso con escala de 4 puntos.

• **Índices de Control de Validez del Protocolo:**

1. **Índice F (Falsificación / Deseabilidad Inversa):** Detecta tendencia a sobrerreportar patología extrema.
2. **Índice L (Mentira / Buena Imagen):** En autoinforme, mide falseamiento en sentido favorable ("hago siempre caso a la primera").
3. **Índice V (Inconsistencia / Respuestas Inauditas):** Reactivos sin sentido lógico ("duermo 50 horas seguidas") para anular respuestas aleatorias.

• **Conversión Normativa:** Transformación automática de puntuaciones directas a **Puntuaciones T** (Media = 50, DT = 10) y Percentiles mediante baremos generales y clínicos estratificados por edad y sexo.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Rango Clínico T	Rango T Adaptativo	Interpretación y Significación Diagnóstica
Muy Significativo	$T \geq 70$	$T \leq 30$	Patología severa o déficit adaptativo crítico; requiere intervención clínica urgente.
En Riesgo	$60 \leq T \leq 69$	$31 \leq T \leq 40$	Zona de vulnerabilidad latente; necesidad de monitorización y apoyo preventivo.
Promedio Típico	$41 \leq T \leq 59$	$41 \leq T \leq 59$	Desarrollo normativo infantil; equilibrio entre demandas y recursos personales.
Bajo	$T \leq 40$	$T \geq 60$	Ausencia de síntomas patológicos o fortaleza adaptativa sobresaliente (ej. alto liderazgo).

SIGNIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE DISCREPANCIAS ENTRE INFORMADORES:

Si un menor puntúa en rango clínicamente significativo ($T \geq 70$) en Profesores (TRS) pero en rango normal ($T < 55$) en Padres (PRS), debe explorarse de inmediato la existencia de acoso escolar encubierto, dislexia o dificultades de integración grupal en el centro educativo.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y DISEÑO DE INTERVENCIÓN ESCOLAR-FAMILIAR

PROTOCOLO SECUENCIAL DE TRIANGULACIÓN DIAGNÓSTICA:

- **Paso 1 (Cálculo de Índices de Control):** Verificar la validez formal de los protocolos (índices F, L, V e inconsistencia). Si F es elevado, contrastar con entrevista clínica para descartar dramatización.
- **Paso 2 (Análisis de los Índices Compuestos Globales):** Si Problemas Exteriorizados $T \geq 70$, priorizar manejo conductual y control de impulsos. Si Problemas Interiorizados $T \geq 70$, priorizar cribado de ideación depresiva y desensibilización fóbica.
- **Paso 3 (Triangulación Cruzada Padres - Profesores - Menor):** Establecer en qué contextos emergen las conductas disfuncionales. Las conductas omnipresentes sugieren etiología neurobiológica (ej. TDAH); las contextuales sugieren contingencias ambientales.
- **Paso 4 (Potenciación de Habilidades Adaptativas):** Utilizar las áreas adaptativas preservadas (ej. Habilidades Sociales intactas) como palanca coterapéutica para compensar los déficits atencionales o conductuales.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN TDAH COMBINADO Y DESAJUSTE ESCOLAR

Identificación: Niño de 9 años, derivado por el orientador escolar ante disrupción continuada en el aula, llamadas de atención, desobediencia a la tutora, olvido masivo de tareas y fracaso escolar en tercero de primaria.

Resultados Psicométricos BASC-3 (Puntuaciones T):

- **Evaluación Profesores (TRS):** Hiperactividad = **76T**; Problemas de Atención = **74T**; Agresividad = **66T**; Adaptabilidad = **32T**; Rendimiento Escolar = **30T**.
- **Evaluación Padres (PRS):** Hiperactividad = **71T**; Atención = **69T**; Problemas de Conducta = **58T**; Habilidades Sociales = **48T**.
- **Autoinforme Menor (SRP):** Actitud hacia el colegio = **68T**; Desesperanza = **52T**; Sentido de Incapacidad = **64T**.

Diagnóstico e Intervención: Se confirmó Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), subtipo combinado, con comorbilidad reactiva de desajuste escolar. Se implementó un plan multimodal: inicio de psicoestimulante por neuropsiquiatría, entrenamiento en autoinstrucciones cognitivas (Meichenbaum), economía de fichas coordinada entre colegio y familia, y adaptaciones metodológicas no significativas en el aula.

Reevaluación a los 6 Meses: Los Profesores reportaron un descenso notable en Hiperactividad (**54T**) y Atención (**52T**), normalizando la convivencia y aprobando todas las materias.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALTA DEPRESIÓN EN AUTOINFORME (SRP):

Una puntuación $T \geq 70$ en Depresión o Sentido de Incapacidad en el autoinforme del niño, aun cuando los padres lo califiquen como "normal", exige descartar ideación autolítica y ciberacoso.

TDAH VS. ANSIEDAD INFANTIL:

Un menor con alta inquietud motriz y problemas atencionales puede presentar un Trastorno de Ansiedad Generalizada en lugar de TDAH; analizar somatizaciones y miedos específicos en el BASC-3.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Reynolds, C. R., & Kamphaus, R. W. (2015). *Behavior Assessment System for Children, Third Edition (BASC-3): Professional manual*. Pearson Assessment.
2. González, J., Fernández-Pinto, I., Santamaría, P., Reynolds, C. R., & Kamphaus, R. W. (2018). *BASC-3: Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes. Manual de aplicación y corrección*. Pearson Clinical España.
3. Kamphaus, R. W., & Reynolds, C. R. (2007). *Translating psychological research into educational practice with the BASC-2*. Springer.
4. Tan, C. S. (2017). Test review of the Behavior Assessment System for Children, Third Edition (BASC-3). *Journal of Psychoeducational Assessment*, 35(5), 528-535.